चिकित्सीय आहार: ज्वर और टाइफाइड

Therapeutic Diet: Fever and Typhoid

चिकित्सीय आहार (Therapeutic Diet) वह आहार है जिसमें रोग, पोषण-अवस्था और पाचन-सहनशीलता के अनुसार सामान्य संतुलित आहार में परिवर्तन किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्याप्त पोषण देना और स्वास्थ्यलाभ में सहायता करना है।

ज्वर एक लक्षण है, जबकि टाइफाइड एक विशिष्ट जीवाणुजनित रोग है। दोनों में भोजन की योजना बनाते समय रोग की तीव्रता, भूख, जल की हानि और आंत्र संबंधी लक्षणों को समझना आवश्यक है।

अध्ययन के प्रमुख आधार (Key Areas)

आधार	अध्ययन का विषय
रोग की अवस्था	ज्वर, भूख में कमी और पाचन संबंधी लक्षण
पोषण	ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज
जल-संतुलन	तरल, इलेक्ट्रोलाइट और निर्जलीकरण
भोजन का स्वरूप	सामान्य, नरम और आवश्यकता अनुसार तरल
स्वास्थ्यलाभ	पर्याप्त सेवन और सामान्य आहार की ओर वापसी

आहार की भूमिका (Role of Diet)

पोषण-योजना रोग के उपचार का सहयोगी भाग है। टाइफाइड में उपयुक्त चिकित्सकीय उपचार आवश्यक है; केवल विशेष भोजन देने से संक्रमण समाप्त नहीं होता।

> सही आहार का आधार रोगी की जरूरत और सहनशीलता है। एक ही सूची, मात्रा या भोजन-सारणी सभी रोगियों पर लागू नहीं होती।

1. चिकित्सीय आहार की संकल्पना

Concept of a Therapeutic Diet

सामान्य संतुलित आहार शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। चिकित्सीय आहार में इसी आधार को रोग की जरूरतों के अनुसार बदला जाता है। परिवर्तन पोषक तत्त्वों, बनावट, मात्रा और भोजन की आवृत्ति में हो सकता है।

परिवर्तन	उदाहरण
बनावट (Texture)	सामान्य भोजन को नरम या मसलकर देना
पोषण-सघनता (Nutrient Density)	छोटे भाग में अधिक ऊर्जा और प्रोटीन देना
आवृत्ति (Frequency)	बड़े भोजन के स्थान पर छोटे भोजन देना
घटकों का चयन	असहनीय पदार्थ के उपयुक्त विकल्प रखना
तरल का प्रबंधन	हानि, सेवन और सहवर्ती रोग के अनुसार

पोषण की पर्याप्तता (Nutritional Adequacy)

हल्का भोजन ऐसा होना चाहिए जो स्वीकार्य भी हो और आवश्यक पोषण भी दे। केवल चावल का पानी या बहुत पतला सूप लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होता।

व्यक्तिगत योजना (Individual Planning)

आयु, शरीर का आकार, वजन में परिवर्तन, बीमारी की अवधि तथा गुर्दे या हृदय के रोग योजना बदल सकते हैं।

> चिकित्सीय आहार का अर्थ केवल भोजन की सूची से कुछ पदार्थ हटाना नहीं; हटाए गए पोषण का उचित विकल्प देना भी आवश्यक है।

2. ज्वर का अर्थ और स्वरूप

Meaning and Nature of Fever

ज्वर (Fever) में शरीर का ताप-नियामक केंद्र अधिक ताप के स्तर पर कार्य करने लगता है। यह केंद्र हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) में स्थित है। वयस्क में लगभग 38 °C या अधिक ताप सामान्यतः ज्वर माना जाता है; मापने का स्थान और परिस्थिति महत्त्वपूर्ण हैं।

आधार	अर्थ
ज्वर	ताप-नियामक स्तर का बढ़ना
अतितापन (Hyperthermia)	ताप बढ़ना, पर वही नियामक परिवर्तन आवश्यक नहीं
अल्पकालिक अवस्था	कम अवधि की बीमारी और अस्थायी सेवन-कमी
लंबी बीमारी	लंबे समय तक पोषण-कमी और वजन घटने का जोखिम

कारण की पहचान (Identifying the Cause)

संक्रमण ज्वर का सामान्य कारण है, लेकिन हर ज्वर संक्रमण या टाइफाइड नहीं होता। रोग का कारण समझे बिना केवल भोजन बदलना पर्याप्त नहीं है।

आहार से संबंध (Dietary Relevance)

कम अवधि में तरल और स्वीकार्य भोजन प्रमुख होते हैं। लंबी बीमारी में कुल ऊर्जा, प्रोटीन और वजन की निगरानी विशेष महत्त्व रखती है।

> ज्वर एक लक्षण है। उसका कारण, अवधि और रोगी की स्थिति पोषण-योजना को दिशा देते हैं।

3. ज्वर का पोषण पर प्रभाव

Nutritional Effects of Fever

बीमारी के दौरान शरीर की चयापचयी जरूरतें और भोजन का सेवन विपरीत दिशाओं में बदल सकते हैं। एक ओर आवश्यकता बढ़ सकती है, दूसरी ओर भूख घट सकती है।

परिवर्तन	संभावित परिणाम
भूख में कमी (Poor Appetite)	ऊर्जा और प्रोटीन का कम सेवन
चयापचयी तनाव (Metabolic Stress)	ऊर्जा की जरूरत में बदलाव
ऊतक-अपघटन (Catabolism)	मांसपेशियों और प्रोटीन भंडार पर प्रभाव
पसीना तथा अन्य हानि	जल और इलेक्ट्रोलाइट में कमी
थकान या मितली	भोजन लेने में कठिनाई

ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन (Negative Nitrogen Balance)

जब शरीर से नाइट्रोजन का निकलना उसके ग्रहण से अधिक होता है, तो ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन बनता है। यह शरीर के प्रोटीन के क्षय से संबंधित हो सकता है।

बीमारी की अवधि (Duration of Illness)

कुछ समय की भूख-कमी और कई दिनों तक बहुत कम सेवन का प्रभाव समान नहीं है। अवधि बढ़ने पर वजन तथा कार्यक्षमता की हानि का जोखिम बढ़ता है।

> ज्वर में पर्याप्त आहार का लक्ष्य केवल ताप घटाना नहीं; पोषण-कमी और अनावश्यक ऊतक-हानि सीमित करना भी है।

4. आहार बनाने से पहले मूल्यांकन

Assessment Before Diet Planning

पोषण-योजना रोगी के वास्तविक सेवन और लक्षणों पर आधारित होनी चाहिए। केवल बीमारी का नाम पर्याप्त जानकारी नहीं देता।

जानकारी	उपयोग
आयु और शरीर का आकार	मूल पोषण आवश्यकता समझना
वर्तमान तथा पूर्व वजन	वजन घटने का पता लगाना
भोजन का सेवन (Food Intake)	क्या और कितना खाया जा रहा है
पाचन संबंधी लक्षण	मितली, उलटी, दस्त, कब्ज और पेट-दर्द
तरल का सेवन (Fluid Intake)	जल की उपलब्धता और ग्रहण
सहवर्ती रोग (Comorbidities)	शर्करा, प्रोटीन और तरल के परिवर्तन

सरल सेवन-अभिलेख (Intake Record)

समय, दिया गया भोजन, वास्तव में खाया गया भाग और उसके बाद के लक्षण लिखने से योजना में सुधार किया जा सकता है। केवल भोजन परोसना पर्याप्त सेवन का प्रमाण नहीं है।

निगरानी (Monitoring)

जल की कमी से वजन जल्दी बदल सकता है। ऐसे बदलाव को हमेशा मांसपेशी या वसा की वास्तविक हानि न मानें।

> मूल्यांकन में रोग की स्थिति और पोषण-अवस्था दोनों शामिल हों। योजना को आवश्यकता अनुसार संशोधित करें।

5. ऊर्जा की आवश्यकता

Energy Requirements

ज्वर और संक्रमण में ऊर्जा की आवश्यकता बदल सकती है। बीमारी की तीव्रता, अवधि, शरीर का आकार, गतिविधि और पूर्व पोषण-अवस्था इस बदलाव को प्रभावित करते हैं।

स्थिति	योजना का आधार
भूख कम	छोटे भाग और स्वीकार्य भोजन
वजन घट रहा हो	कुल सेवन तथा ऊर्जा की पर्याप्तता जाँचना
लंबे समय से बीमारी	पोषण-कमी का जोखिम पहचानना
सहवर्ती मधुमेह	ऊर्जा के साथ कार्बोहाइड्रेट का वितरण

पर्याप्तता और अतिरेक (Adequacy and Excess)

आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा दें। हर हल्के ज्वर में बहुत अधिक भोजन या शर्करा देना आवश्यक नहीं है। कम भूख वाले रोगी में धीरे-धीरे पर्याप्त सेवन प्राप्त करना उपयोगी है।

छोटे भाग में ऊर्जा (Energy Density)

सहनशीलता के अनुसार खिचड़ी, दलिया, दूध से बनी तैयारी या थोड़ी वसा से भोजन का योगदान बढ़ाया जा सकता है। बहुत पतला भोजन पेट भर सकता है, पर ऊर्जा कम दे सकता है।

> ताप में बढ़ोतरी को एक निश्चित प्रतिशत से गुणा करके सभी रोगियों की ऊर्जा जरूरत तय नहीं की जा सकती। वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन आवश्यक है।

6. प्रोटीन की भूमिका

Role of Protein

प्रोटीन (Protein) ऊतक संरक्षण, मरम्मत और शरीर की अनेक कार्यात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। लंबे संक्रमण और कम सेवन में इसका महत्त्व बढ़ जाता है।

खाद्य विकल्प	उपयोग का तरीका
दाल	अच्छी तरह पकी, मसलकर या खिचड़ी में
दूध और दही	सुरक्षित तथा सहन होने पर
पनीर	नरम तैयारी में, उपयुक्त मात्रा
अंडा	पूरी तरह पका हुआ
मछली या मांस	खाने की आदत के अनुसार अच्छी तरह पका नरम रूप

ऊर्जा और प्रोटीन का संबंध (Energy-Protein Relationship)

ऊर्जा बहुत कम मिलने पर प्रोटीन का कुछ भाग ऊर्जा के लिए उपयोग हो सकता है। इसलिए केवल प्रोटीन बढ़ाना, कुल ऊर्जा की पर्याप्तता का विकल्प नहीं है।

दाल का पानी (Strained Dal Water)

छानी हुई दाल के पानी में पूरी पकी दाल की तुलना में कम प्रोटीन और अन्य पोषक तत्त्व हो सकते हैं। सहन होने पर मसलकर पूरी तैयारी देना बेहतर योगदान देता है।

> प्रोटीन की मात्रा रोगी की जरूरत के अनुसार हो। गुर्दे की बीमारी जैसी स्थितियों में सामान्य उच्च-प्रोटीन योजना सीधे लागू न करें।

7. कार्बोहाइड्रेट और वसा

Carbohydrates and Fat

कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। वसा (Fat) छोटे भाग में ऊर्जा बढ़ाती है, पर अधिक तली या चिकनी तैयारी कुछ रोगियों को असहनीय लग सकती है।

घटक	संभावित विकल्प	विचारणीय बिंदु
अनाज	चावल, सूजी, दलिया और नरम रोटी	रूप और मात्रा सहनशीलता अनुसार
स्टार्चयुक्त पदार्थ	नरम आलू और अनाज की तैयारी	भोजन में विविधता
शर्करा	जरूरत के अनुसार सीमित प्रयोग	अतिरिक्त मीठा अनिवार्य नहीं
वसा	थोड़ी मात्रा में तेल या घी	कुल मात्रा और लक्षण

ऊर्जा का संतुलन (Energy Balance)

ऊर्जा बढ़ाने के लिए केवल मीठे पेय देना उचित योजना नहीं है। आहार में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्त्व भी बने रहने चाहिए।

वसा का चयन (Choice of Fat)

सभी रोगियों के लिए वसा पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं। अधिक तले भोजन और भारी तैयारी को सीमित करना, आवश्यक वसा को पूरी तरह हटाने से अलग है।

> भोजन की वास्तविक सामग्री महत्त्वपूर्ण है। “हल्का” या “पौष्टिक” नाम मात्र से ऊर्जा और वसा की मात्रा निश्चित नहीं होती।

8. जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन

Water and Electrolyte Balance

ज्वर में पसीना, कम पीना और साथ होने वाले दस्त या उलटी से जल की कमी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट (Electrolytes) वे आयन हैं जो जल-संतुलन तथा शरीर के कार्यों में योगदान देते हैं।

पक्ष	क्या देखना चाहिए?
सेवन	पानी और अन्य सुरक्षित तरल की मात्रा
हानि	दस्त, उलटी, पसीना और अन्य हानियाँ
लक्षण	प्यास, मुँह सूखना और पेशाब कम होना
सहवर्ती रोग	तरल या इलेक्ट्रोलाइट सीमित करने की जरूरत

तरल के विकल्प (Fluid Choices)

सुरक्षित पानी, उपयुक्त सूप और सहन होने वाली दूध-आधारित तैयारी योगदान दे सकती हैं। हर पेय की पोषण-संरचना और इलेक्ट्रोलाइट मात्रा समान नहीं होती।

मात्रा का निर्धारण (Determining Fluid Needs)

सभी रोगियों के लिए एक ही लीटर मात्रा तय नहीं होती। हानि, आयु और चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार जरूरत बदलती है। हृदय या गुर्दे की बीमारी में विशेष योजना आवश्यक हो सकती है।

> पानी, नारियल पानी और पुनर्जलीकरण घोल एक-दूसरे के पूर्ण विकल्प नहीं हैं। उनकी संरचना और उपयोग अलग हैं।

9. मौखिक पुनर्जलीकरण घोल

Oral Rehydration Solution

मौखिक पुनर्जलीकरण घोल को ORS (Oral Rehydration Solution) कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज़ और लवण निर्धारित अनुपात में होते हैं। यह विशेष रूप से दस्त से हुई जल और इलेक्ट्रोलाइट हानि की पूर्ति में उपयोगी है।

आधार	आवश्यक बात
तैयारी (Preparation)	पैकेट पर लिखी जल की मात्रा का पालन
जल	सुरक्षित पेयजल का उपयोग
अनुपात (Dilution)	कम या अधिक जल से सांद्रता बदलती है
अतिरिक्त सामग्री	चीनी, दूध, रस या अतिरिक्त नमक न मिलाना
संरक्षण	स्वच्छ पात्र और पैकेट के रखरखाव निर्देश

उपयोग की सीमा (Limitations)

ORS पर्याप्त भोजन का विकल्प नहीं है और टाइफाइड के जीवाणु को समाप्त नहीं करता। केवल ज्वर होने पर हर रोगी को ORS देना अनिवार्य नहीं है।

ग्रहण में कठिनाई (Difficulty Drinking)

मितली में छोटे घूँट देना सहायक हो सकता है। लगातार उलटी, तरल न टिकना या गंभीर निर्जलीकरण में चिकित्सकीय उपचार आवश्यक है।

> हर ORS पैकेट एक लीटर के लिए नहीं होता। पैकेट पर दिया गया अनुपात ही अपनाएँ; अनुमान से घोल न बनाएँ।

10. विटामिन और खनिज

Vitamins and Minerals

पर्याप्त विविध आहार शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं और स्वास्थ्यलाभ के लिए आवश्यक विटामिन व खनिज उपलब्ध कराता है। कम सेवन या लंबी बीमारी में इनके योगदान पर ध्यान देना चाहिए।

घटक	सामान्य भूमिका
B समूह के विटामिन (B Vitamins)	ऊर्जा और अन्य चयापचयी प्रक्रियाएँ
विटामिन C (Vitamin C)	संयोजी ऊतक और सामान्य शारीरिक कार्य
जस्ता (Zinc)	वृद्धि, ऊतक-मरम्मत और प्रतिरक्षा कार्य
आयरन (Iron)	हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन परिवहन
सोडियम और पोटैशियम	जल-संतुलन और तंत्रिका-मांसपेशी कार्य

खाद्य योगदान (Food Sources)

पकी सब्जियाँ, उपयुक्त फल, दालें और दूध-आधारित पदार्थ सहनशीलता के अनुसार आहार में रखे जा सकते हैं। किसी खाद्य वर्ग को बिना कारण लंबे समय तक हटाने से पर्याप्तता प्रभावित होती है।

पूरक का निर्णय (Supplementation)

कमी, विशेष जरूरत या चिकित्सकीय संकेत होने पर पूरक दिए जा सकते हैं। केवल ज्वर के कारण सभी विटामिनों की बड़ी खुराक आवश्यक नहीं होती।

> विटामिन या खनिज की गोली ऊर्जा, प्रोटीन और पर्याप्त भोजन की कमी को पूरा नहीं करती।

11. भोजन की बनावट और आवृत्ति

Food Texture and Meal Frequency

भोजन का रूप चबाने, निगलने और पाचन-सहनशीलता के अनुसार चुना जाता है। ज्वर होते ही सभी ठोस पदार्थ बंद करना आवश्यक नहीं है।

रूप	उदाहरण	मुख्य विशेषता
सामान्य आहार (Normal Diet)	संतुलित घरेलू भोजन	सहन होने पर जारी
नरम आहार (Soft Diet)	नरम खिचड़ी, मसली दाल	कम चबाने की जरूरत
पूर्ण तरल (Full Liquid Diet)	दूध आधारित तरल और गाढ़ी तरल तैयारी	पोषण पर्याप्तता जाँचना
स्वच्छ तरल (Clear Liquid Diet)	छना शोरबा और कुछ साफ तरल	प्रायः सीमित अवधि; पोषण कम

छोटे भोजन (Small Frequent Meals)

भूख कम हो तो छोटे भोजन अधिक बार देने से कुल सेवन बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। भोजन का समय रोगी की सुविधा और लक्षणों से जोड़ें।

तरल की सीमा (Limits of Liquid Diets)

तरल होने से भोजन अपने-आप पर्याप्त या आसानी से सहनीय नहीं हो जाता। उसमें ऊर्जा, प्रोटीन तथा शर्करा की मात्रा भी देखनी चाहिए।

> बिना आवश्यकता सभी रोगियों को स्वच्छ तरल से पूर्ण तरल और फिर नरम भोजन के अनिवार्य क्रम में रखना उचित नहीं है।

12. ज्वर में खाद्य चयन

Food Selection During Fever

ज्वर में परिचित, स्वच्छ और सहन होने वाला भोजन चुनें। भोजन का स्वाद, गंध, ताप और भाग का आकार उसकी स्वीकार्यता बदल सकते हैं।

खाद्य वर्ग	संभावित तैयारी
अनाज (Cereals)	नरम चावल, खिचड़ी, दलिया और सूजी
दालें (Pulses)	अच्छी तरह पकी तथा मसलकर दी गई दाल
दूध वर्ग (Dairy Foods)	दूध, दही या नरम पनीर, सहन होने पर
सब्जियाँ	अच्छी तरह पकी और जरूरत अनुसार मसली
फल	सुरक्षित, धुले और आवश्यकतानुसार छिले
पशुजन्य पदार्थ	पूरी तरह पका अंडा या अन्य नरम विकल्प

स्वीकार्यता (Acceptability)

तेज गंध से मितली बढ़ती हो तो कम गंध वाली तैयारी चुनें। किसी पदार्थ से पेट की परेशानी बढ़े तो उसके पोषण का दूसरा विकल्प दें।

सामान्य ज्वर और आंत्र लक्षण (Fever and Gut Symptoms)

केवल ज्वर और ज्वर के साथ गंभीर दस्त या पेट-दर्द की आहार जरूरतें अलग हो सकती हैं।

> सुरक्षित और पर्याप्त घरेलू भोजन कई स्थितियों में उपयोगी है। महँगा विशेष पेय हर रोगी के लिए आवश्यक नहीं होता।

13. ज्वर के लिए नमूना भोजन-योजना

Sample Meal Plan for Fever

यह सामान्य वयस्क के लिए एक शैक्षणिक उदाहरण है। मात्रा, ऊर्जा और विकल्प रोगी की आवश्यकता तथा सहनशीलता के अनुसार निर्धारित किए जाएँ।

समय	संभावित भोजन
सुबह	सुरक्षित पानी; भूख के अनुसार नरम नाश्ता
नाश्ता	दलिया या सूजी की तैयारी; सहन होने पर दूध
मध्याह्न	उपयुक्त फल अथवा दही का छोटा भाग
दोपहर	नरम खिचड़ी, मसली दाल और पकी सब्जी
शाम	दूध आधारित तैयारी या अन्य प्रोटीनयुक्त विकल्प
रात	नरम चावल या रोटी; दाल और उपयुक्त सब्जी
बीच में	जरूरत अनुसार सुरक्षित तरल तथा छोटे भोजन

अनुकूलन (Adaptation)

दूध असहनीय हो तो अन्य प्रोटीन स्रोत चुनें। दस्त, पेट-दर्द या विशेष रोग होने पर सामान्य सूची में परिवर्तन करें।

पर्याप्तता की जाँच (Checking Adequacy)

केवल समय-सारणी बनाना पर्याप्त नहीं। पूरे दिन वास्तव में खाया गया भोजन, प्रोटीन का योगदान तथा तरल का सेवन देखना आवश्यक है।

> नमूना योजना मात्रा-निर्धारित चिकित्सकीय आहार नहीं है। इसे रोगी के मूल्यांकन के अनुसार ढालें।

14. टाइफाइड का परिचय

Introduction to Typhoid

टाइफाइड (Typhoid Fever) साल्मोनेला टाइफी (Salmonella Typhi) नामक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है। यह केवल पेट की बीमारी नहीं; पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला रोग हो सकता है।

आधार	प्रमुख तथ्य
रोगजनक (Pathogen)	साल्मोनेला टाइफी
संचरण (Transmission)	संक्रमित मल से दूषित भोजन या जल
सामान्य लक्षण	ज्वर, कमजोरी और भूख में कमी
आंत्र लक्षण	पेट-दर्द, दस्त या कब्ज
संबंधित रोग	पैराटाइफाइड; दोनों आंत्रिक ज्वर के अंतर्गत

लक्षणों की भिन्नता (Variation in Symptoms)

हर रोगी में सभी लक्षण नहीं होते। दस्त न होने से टाइफाइड की संभावना समाप्त नहीं होती और हर लंबे ज्वर का कारण टाइफाइड नहीं होता।

निदान और उपचार (Diagnosis and Treatment)

चिकित्सकीय मूल्यांकन तथा उपयुक्त परीक्षण आवश्यक हैं। रक्त-संवर्धन (Blood Culture) निदान में महत्त्वपूर्ण है; केवल एक विडाल (Widal) परिणाम से रोग की पुष्टि मानना उचित नहीं है।

> टाइफाइड में आहार उपचार का सहयोगी है। रोग के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय उपचार आवश्यक रहता है।

15. टाइफाइड में आहार के उद्देश्य

Dietary Objectives in Typhoid

टाइफाइड में कम भूख, लंबा ज्वर और पाचन संबंधी लक्षण पोषण को प्रभावित कर सकते हैं। आहार का उद्देश्य पर्याप्त पोषण के साथ सहनशीलता बनाए रखना है।

उद्देश्य	योजना में योगदान
ऊर्जा की पूर्ति (Energy Supply)	वजन और ऊतक-हानि सीमित करना
प्रोटीन की पर्याप्तता	शरीर के प्रोटीन और स्वास्थ्यलाभ में सहायता
जल की पूर्ति (Hydration)	सेवन तथा हानि का संतुलन
पाचन-सहनशीलता	जरूरत अनुसार नरम और छोटे भोजन
खाद्य सुरक्षा (Food Safety)	भोजन से दोबारा दूषण की संभावना घटाना

पोषण की भाषा (Interpreting Nutrient Needs)

ऊर्जा और प्रोटीन की बढ़ी जरूरत हो सकती है। इसका अर्थ हर रोगी को अत्यधिक कैलोरी या एक ही उच्च-प्रोटीन मात्रा देना नहीं है।

उपचार के साथ संबंध (Diet and Treatment)

भोजन से जीवाणु नहीं मिटता। रोग की स्थिति सुधरने पर भूख और भोजन-सहनशीलता बदल सकती है; योजना को उसी अनुसार आगे बढ़ाएँ।

> टाइफाइड की आहार-योजना = पर्याप्त पोषण + उपयुक्त बनावट + तरल-संतुलन + स्वच्छता + व्यक्तिगत अनुकूलन।

16. नरम और कम रेशा वाले आहार

Soft and Low-Fibre Diets

नरम आहार (Soft Diet) तथा कम रेशा वाला आहार (Low-Fibre Diet) अलग अवधारणाएँ हैं। नरम आहार बनावट से संबंधित है, जबकि कम रेशा वाला आहार खाद्य घटकों के चयन से संबंधित है।

आधार	नरम आहार	कम रेशा वाला आहार
प्रमुख परिवर्तन	कठोरता और चबाने की जरूरत	कुल रेशे का योगदान
उदाहरण	अच्छी तरह पका दलिया	आवश्यकता अनुसार परिष्कृत अनाज
चयन	चबाने तथा सहनशीलता के लिए	कुछ आंत्र लक्षणों में अस्थायी उपयोग

दोनों हमेशा समान नहीं (Different Concepts)

नरम पका साबुत अनाज अब भी रेशा दे सकता है। छीलने, छानने और साबुत भाग हटाने से रेशा बदलता है; केवल नरम पकाने से पूरा रेशा समाप्त नहीं होता।

टाइफाइड में उपयोग (Use in Typhoid)

कुछ रोगियों में पेट की परेशानी के दौरान नरम और अस्थायी रूप से कम रेशा वाले विकल्प उपयोगी हो सकते हैं। लंबे समय की सार्वभौमिक पाबंदी आवश्यक नहीं है।

> रेशा रोकने से आंत्र-छिद्रण की रोकथाम सिद्ध नहीं होती। इस जटिलता का संबंध गंभीर रोग से है और उसे चिकित्सकीय उपचार चाहिए।

17. अवस्था के अनुसार आहार में बदलाव

Adapting Diet to the Clinical Condition

आहार का विस्तार लक्षणों, भूख और चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर किया जाता है। निश्चित दिन संख्या से सभी रोगियों का आहार तय नहीं किया जाना चाहिए।

अवस्था	संभावित योजना
भोजन सहन हो रहा हो	पर्याप्त सामान्य या नरम भोजन जारी
मितली और कम भूख	छोटे भाग, कम गंध वाली तैयारी
आंत्र परेशानी	सहनशीलता अनुसार बनावट और घटक बदलना
सुधार (Recovery)	मात्रा और खाद्य विविधता धीरे बढ़ाना
गंभीर जटिलता (Complication)	अस्पताल की चिकित्सकीय पोषण-योजना

अनिवार्य तरल चरण नहीं (No Mandatory Liquid Stage)

हर रोगी को केवल तरल देना जरूरी नहीं। लंबे समय तक अत्यंत सीमित आहार पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन नहीं दे सकता।

गंभीर अवस्था (Severe Illness)

लगातार उलटी, आंत्र-छिद्रण या अन्य गंभीर जटिलता में सामान्य घरेलू भोजन-सारणी लागू नहीं होती। भोजन देने का मार्ग और समय चिकित्सकीय दल तय करता है।

> आहार की प्रगति सहनशीलता और रोग की स्थिति से जुड़ी है; केवल ताप कम होने या कैलेंडर की तारीख से नहीं।

18. टाइफाइड में उपयोगी विकल्प

Suitable Food Choices in Typhoid

खाद्य पदार्थों का चयन भोजन की सुरक्षा, पोषण योगदान और व्यक्तिगत सहनशीलता को देखकर किया जाता है।

खाद्य वर्ग	संभावित विकल्प	विशेष विचार
अनाज	नरम चावल, सूजी और खिचड़ी	ऊर्जा तथा बनावट
दाल	अच्छी तरह पकी छिलका-रहित दाल	सहन होने पर मसलकर
दूध वर्ग	सुरक्षित दूध, दही और नरम पनीर	लैक्टोज-सहनशीलता
अंडा	पूरी तरह पका अंडा	अधपका न देना
सब्जी	पकी और जरूरत अनुसार मसली	रेशा व बनावट का अनुकूलन
फल	सुरक्षित छिला फल या उपयुक्त पकी तैयारी	व्यक्तिगत सहनशीलता

मिश्रित भोजन (Mixed Meals)

खिचड़ी में दाल की मात्रा, पनीर या अन्य विकल्प जोड़कर प्रोटीन का योगदान बढ़ सकता है। केवल नाम देखकर उसकी पर्याप्तता तय नहीं होती।

भोजन का भाग (Portion Size)

छोटे भाग में देना उपयोगी हो सकता है। परंतु पूरे दिन की कुल मात्रा कम न रह जाए, इसकी जाँच करें।

> ये संभावित विकल्प हैं। किसी एक पदार्थ को सभी रोगियों के लिए अनिवार्य भोजन न मानें।

19. किन पदार्थों में बदलाव करें?

Foods Requiring Modification

पाबंदी का कारण स्पष्ट होना चाहिए: दूषण का जोखिम, लक्षण बढ़ना या किसी विशेष पोषक तत्त्व को नियंत्रित करना।

पदार्थ या तैयारी	संभावित कारण
दूषित जल और असुरक्षित बर्फ	संक्रमण का जोखिम
बिना पाश्चुरीकृत दूध	खाद्य सुरक्षा का प्रश्न
अधपका अंडा, मांस या मछली	जीवाणुजनित दूषण का जोखिम
बहुत तला या चिकना भोजन	कुछ रोगियों में असहनीयता
बहुत तीखा भोजन	लक्षण बढ़ने पर परिवर्तन
अधिक रेशा वाली कठोर तैयारी	कुछ आंत्र लक्षणों में अस्थायी कमी

सुरक्षा और रेशा में अंतर (Safety and Fibre)

कच्चे सलाद में दूषण का जोखिम और उसकी रेशा मात्रा दो अलग बातें हैं। पकाने से सुरक्षा तथा बनावट बदलती है; रेशा पूरी तरह समाप्त नहीं होता।

जरूरत अनुसार वापसी (Reintroducing Foods)

जिस भोजन को अस्थायी रूप से हटाया गया है, सुधार होने पर उसे उचित रूप में वापस शामिल किया जा सकता है।

> हर फल, हर सब्जी और हर दूध पदार्थ पर स्थायी रोक लगाना पोषण की पर्याप्तता घटा सकता है।

20. टाइफाइड की नमूना भोजन-योजना

Sample Meal Plan for Typhoid

यह उदाहरण ऐसे वयस्क के लिए है जो मुख से भोजन ले सकता है और नरम भोजन सहन कर रहा है। गंभीर जटिलता में यह योजना लागू नहीं होती।

समय	संभावित भोजन
सुबह	सुरक्षित पानी; भूख के अनुसार छोटा भोजन
नाश्ता	नरम सूजी या दलिया; सहन होने पर दूध
बीच का भोजन	सुरक्षित छिला नरम फल या अन्य सहनीय विकल्प
दोपहर	नरम चावल-दाल की खिचड़ी और पकी मसली सब्जी
शाम	दही, नरम पनीर या पूरी तरह पके अंडे का विकल्प
रात	नरम चावल, मसलकर पकी दाल और उपयुक्त सब्जी
अन्य समय	जरूरत अनुसार सुरक्षित तरल और छोटे भाग

लक्षण के अनुसार परिवर्तन (Symptom-Based Adaptation)

लैक्टोज से परेशानी हो तो दूध के स्थान पर अन्य प्रोटीन स्रोत चुनें। दस्त में पुनर्जलीकरण की जरूरत अलग से देखें।

मात्रा का प्रश्न (Quantities and Intake)

प्रत्येक पदार्थ की मात्रा, वास्तविक सेवन और पूरे दिन की ऊर्जा-प्रोटीन पर्याप्तता का निर्धारण अलग से आवश्यक है।

> केवल चावल का पानी, दाल का पानी और फल-रस देते रहना इस संतुलित योजना का विकल्प नहीं है।

21. दस्त, कब्ज और दूध-सहनशीलता

Diarrhoea, Constipation and Milk Tolerance

टाइफाइड में दस्त (Diarrhoea) या कब्ज (Constipation) दोनों हो सकते हैं। इन लक्षणों के अनुसार योजना बदलती है; एक ही पाबंदी सब पर लागू नहीं होती।

स्थिति	विचारणीय परिवर्तन
दस्त	तरल-इलेक्ट्रोलाइट पूर्ति और सहनीय भोजन
अधिक मीठे पेय से परेशानी	शर्करा-युक्त पेय सीमित करना
दूध से गैस या दस्त	लैक्टोज-सहनशीलता का मूल्यांकन
कब्ज	जल, आहार और चिकित्सकीय स्थिति का पुनर्मूल्यांकन

उपवास का प्रश्न (Fasting)

साधारण तीव्र दस्त में बिना कारण भोजन रोकना उचित नहीं है। सहन होने वाला भोजन जारी रखें। गंभीर आंत्र स्थिति में चिकित्सकीय निर्णय अलग हो सकता है।

दूध और विकल्प (Milk Tolerance)

अस्थायी लैक्टोज-असहनीयता (Lactose Intolerance) कुछ लोगों में हो सकती है। इसका अर्थ सभी रोगियों में सभी दूध पदार्थ बंद करना नहीं है।

कब्ज में सावधानी (Constipation Management)

टाइफाइड के साथ पेट-दर्द या सूजन होने पर अचानक बहुत रेशा या स्वयं जुलाब देना उचित नहीं। कारण की जाँच आवश्यक है।

> पाचन संबंधी लक्षण आहार में परिवर्तन का संकेत देते हैं; केवल रोग का नाम पूर्ण योजना नहीं बताता।

22. कम भूख में भोजन समृद्ध करना

Enriching Food During Poor Appetite

भोजन-समृद्धि (Food Enrichment) में कम मात्रा वाले भोजन की ऊर्जा या प्रोटीन बढ़ाई जाती है। इसका उपयोग कम भूख में पर्याप्त सेवन प्राप्त करने के लिए हो सकता है।

मूल तैयारी	संभावित सुधार
केवल चावल	अच्छी तरह पकी दाल के साथ देना
बहुत पतला दलिया	सहन होने पर दूध या अन्य प्रोटीन विकल्प
सब्जी की तैयारी	नरम पनीर या अन्य उपयुक्त घटक जोड़ना
खिचड़ी	दाल की पर्याप्त मात्रा तथा थोड़ी वसा
केवल साफ सूप	सहनीय, पोषण देने वाले घटक शामिल करना

सीमित मात्रा का लाभ (More Nutrition per Portion)

बहुत अधिक जल से पतला किया गया भोजन पेट भर सकता है। गाढ़ापन और पोषण-सघनता बढ़ाने से छोटे भाग का योगदान बढ़ सकता है।

लक्षण का ध्यान (Considering Symptoms)

अधिक वसा या बहुत गाढ़ी तैयारी असहनीय हो तो दूसरा तरीका अपनाएँ। स्वाद और पोषण दोनों को ध्यान में रखें।

> समृद्धि का अर्थ केवल चीनी या घी बढ़ाना नहीं है। ऊर्जा के साथ प्रोटीन और अन्य पोषक तत्त्व भी आवश्यक हैं।

23. स्वास्थ्यलाभ के समय आहार

Diet During Convalescence

ज्वर कम होने के बाद भी भूख, शक्ति और पूर्व वजन लौटने में समय लग सकता है। इस अवस्था में अनावश्यक पाबंदी हटाना और पर्याप्त भोजन देना आवश्यक है।

लक्ष्य	योजना
कुल सेवन बढ़ाना	सहनशीलता अनुसार भाग और आवृत्ति
प्रोटीन की पर्याप्तता	दाल, दूध वर्ग या अन्य उपयुक्त स्रोत
खाद्य विविधता (Food Variety)	अनाज, फल और सब्जियों की वापसी
सामान्य बनावट	धीरे-धीरे परिचित संतुलित भोजन
निगरानी (Monitoring)	वजन, भूख और कार्यक्षमता

रेशे की वापसी (Restoring Fibre)

यदि रेशा अस्थायी रूप से कम किया गया था, तो सुधार के साथ सहनीय खाद्य पदार्थ बढ़ाए जा सकते हैं। लंबे समय तक बहुत सीमित आहार जारी रखना आवश्यक नहीं है।

धीरे-धीरे विस्तार (Gradual Progression)

एक साथ बहुत बड़े भोजन के स्थान पर भाग और विविधता बढ़ाएँ। फिर भी पोषण-कमी बनी हो तो उसका मूल्यांकन आवश्यक है।

> स्वास्थ्यलाभ का लक्ष्य सामान्य संतुलित आहार की ओर लौटना है; बीमारी वाला सीमित आहार अनिश्चित समय तक जारी रखना नहीं।

24. खाद्य स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण

Food Hygiene and Infection Control

टाइफाइड का भोजन और जल से संबंध होने के कारण आहार की सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अच्छी पोषण-संरचना वाला दूषित भोजन भी सुरक्षित नहीं होता।

क्षेत्र	आवश्यक व्यवहार
हाथ (Hand Hygiene)	शौच के बाद और भोजन से पहले साबुन से धोना
जल	सुरक्षित पेयजल तथा सुरक्षित बर्फ
पकाना	भोजन अच्छी तरह पकाना
दूध	पाश्चुरीकृत या सुरक्षित उबला दूध
फल	सुरक्षित जल से धोना और जरूरत अनुसार छीलना
रसोई	कच्चे और तैयार भोजन का दूषण रोकना

परोसना और रखना (Serving and Storage)

ताजा पका भोजन स्वच्छ पात्र में दें। भोजन को लंबे समय अनुचित ताप पर रखने और दूषित हाथों से छूने से बचाएँ।

रोगी की भूमिका (Preventing Transmission)

टाइफाइड से प्रभावित व्यक्ति दूसरों का भोजन तैयार या परोसने से बचे। बीमारी कम होने के बाद भी संक्रमण-नियंत्रण के निर्देश महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

> टीकाकरण होने पर भी भोजन और जल की सुरक्षा आवश्यक है। स्वच्छता तथा पोषण एक-दूसरे के पूरक हैं।

25. गंभीर संकेत और विशेष स्थितियाँ

Serious Signs and Special Situations

कुछ लक्षण केवल आहार बदलने से संभाले जाने वाली स्थिति नहीं हैं। इनमें तुरंत चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है।

संकेत	संभावित चिंता
तेज या बढ़ता पेट-दर्द	गंभीर आंत्र जटिलता
पेट में अधिक सूजन	आंत्र संबंधी समस्या
मल में रक्त या काला मल	रक्तस्राव की संभावना
लगातार उलटी, तरल न टिकना	निर्जलीकरण और अन्य जटिलता
भ्रम या असामान्य सुस्ती	गंभीर बीमारी
पेशाब बहुत कम होना	जल की कमी या अन्य समस्या

आयु और सहवर्ती रोग (Age and Comorbidities)

बच्चों की जरूरतें वयस्क की सारणी से तय नहीं होतीं। स्तनपान सामान्यतः जारी रखा जाता है। वृद्ध, गर्भवती और गुर्दे या हृदय के रोग वाले व्यक्तियों में विशेष मूल्यांकन आवश्यक है।

मधुमेह (Diabetes)

मीठे पेय से ऊर्जा बढ़ाने की सामान्य योजना मधुमेह में सीधे लागू नहीं होती। भोजन तथा शर्करा-नियंत्रण को साथ देखना चाहिए।

> गंभीर पेट-दर्द, रक्तस्राव या चेतना में बदलाव में भोजन-सूची सुधारने के लिए उपचार में विलंब न करें।

26. तुलना और त्वरित पुनरावृत्ति

Comparison and Quick Revision

आधार	सामान्य ज्वर	टाइफाइड
स्वरूप	अनेक कारणों का लक्षण	विशिष्ट जीवाणुजनित रोग
आहार का मुख्य लक्ष्य	तरल और पर्याप्त सहनीय भोजन	पर्याप्त पोषण, आंत्र-सहनशीलता और सुरक्षा
बनावट	सामान्य या जरूरत अनुसार नरम	अवस्था और लक्षण अनुसार
रेशा	बिना कारण सार्वभौमिक रोक नहीं	कुछ लक्षणों में अस्थायी परिवर्तन
उपचार संबंध	कारण की पहचान आवश्यक	उपयुक्त चिकित्सकीय उपचार आवश्यक

स्मरणीय बिंदु (Key Points)

- ऊर्जा और प्रोटीन की जरूरत का निर्धारण व्यक्ति की स्थिति से होता है।
- छोटे भोजन कम भूख में कुल सेवन बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।
- नरम और कम रेशा वाले आहार पूर्ण पर्याय नहीं हैं।
- ORS जल-इलेक्ट्रोलाइट पूर्ति देता है; पर्याप्त भोजन का विकल्प नहीं।
- स्वास्थ्यलाभ में सामान्य संतुलित आहार की ओर लौटें।

> आहार का मूल्यांकन नाम से नहीं, वास्तविक सेवन, पोषण की पर्याप्तता, सहनशीलता और सुरक्षा से करें।